



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Tecnología Médica



Percepción del desempeño ocupacional de cuidadores de personas
con demencia, en un centro de salud mental comunitario, Lima –
2025

Proyecto de tesis para optar el título profesional de Licenciada en Tecnología Médica en el
Área de Terapia Ocupacional

Autora:

Bachiller, Kelly Rodriguez Arostegui

ASESORA:

DRA. JOACHIN DEL CARPIO MERY MARGOT

Docente Auxiliar / Tiempo Parcial

LIMA – PERÚ

2025

ÍNDICE	
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	3
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA	4
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	4
1.4 OBJETIVOS	5
1.4.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	5
1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO	6
CAPÍTULO II: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS	7
2.1 MARCO TEÓRICO	7
2.1.1 ANTECEDENTES	7
2.1.2 BASE TEÓRICA	10
2.1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	21
2.1.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS	23
2.1.5 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN	23
2.2 DISEÑO METODOLÓGICO	25
2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	25
2.2.2 POBLACIÓN	25
2.2.3 MUESTRA Y MUESTREO	25
2.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN	26
2.2.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN	26
2.2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	26
2.2.7 PLAN DE RECOLECCIÓN	27
2.2.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS	28
2.2.9 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD	28
2.2.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS	29
CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	30
3.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO	30
3.2 PRESUPUESTO	31
3.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	32
3.4 RECURSOS DISPONIBLES	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
ANEXOS	39

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostuvo que la salud mental ha tenido mayor expresión funcional en el sistema de salud primario, debido al aumento de las enfermedades psicológicas y/o psiquiátricas por los diferentes acontecimientos que ha venido ocurriendo a nivel mundial, uno de los eventos más recientes fue la pandemia por la COVID 19, que originó incertidumbre y consigo problemas de ansiedad, estrés, entre otros (1).

Otra de las razones y/o casos que se han visto en ascenso, es el envejecimiento demográfico, siendo el aumento progresivo de la proporción de las personas adultas mayores con respecto a la población en total, esta población está asociada al aumento de las enfermedades no transmisibles y/o degenerativas (2). La Organización Panamericana de Salud (OPS) en el 2022, describió al término “no transmisibles” a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda, sino que dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados, sus condiciones incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas y trastornos de salud mental (3).

Entre ellas, se encuentra la demencia, que es un síndrome que provoca el deterioro de la memoria, comportamiento y la capacidad de realizar sus actividades de vida diaria; además, esta síndrome se encuentra cada vez más presente en las sociedades y las familias (4). La OMS en el año 2023, manifestó que aumentarán en un 40% a nivel mundial en menos de 10 años, alcanzando a más de 78 millones en el 2030, con una prevalencia más marcada entre las mujeres que entre hombres (5).

En Latinoamérica, la demencia afecta al paciente llegando incluso a volverlos dependientes y por ende, tener la necesidad de un cuidador principal, quien también se ve afectado por otros tipos de problemas de salud; debido a las tareas de cuidado que se combinan con mayor frecuencia con las tareas del hogar, el cautiverio de roles y la soledad que padecen los cuidadores debido a la falta de tiempo y/o la necesidad de permanecer con la persona con demencia la mayor parte del día, y también a la tensión financiera, desencadenando un desequilibrio ocupacional y

llegando a tener dificultades en sus áreas de desempeño ocupacional, ya que es común que el rol de cuidador lo asuma un familiar de la persona con demencia (6). El World Alzheimer Report (2022), menciona que, en algunos países, la tecnología suele aminorar la carga que se ve evidenciada en el cuidador, los gobiernos locales y las corporaciones privadas podrían brindar internet como parte de su responsabilidad social, pero en muchos países latinoamericanos aún se viven múltiples desafíos, especialmente en áreas rurales (7).

Custodio N (2016), menciona que en el Perú, el 80% de cuidadores principales son mujeres, el 60% suelen ser las hijas, cónyuge (30%), ya que es poco frecuente que la familia actúe en conjunto para el cuidado de la persona con demencia; el 40% de los cuidadores no reciben ayuda de otras personas, ni siquiera de familiares cercanos, por ese motivo se origina el “síndrome del cuidador quemado”, donde el cuidador termina detestando su rol, debido a que se han descuidado de ellos mismos, dejando de lado sus áreas de ocupaciones, y en algunos casos a la persona con demencia, requiriendo también ayuda médica para su recuperación (8).

Por todo lo ya mencionado es importante y se espera que el cuidador reconozca el rol que realiza, identifique las características y/o demandas que tiene su labor, la carga que trae consigo; para lograr ser capaz de percibir su desempeño y conseguir su equilibrio ocupacional para que la persona esté libre de enfermedades y pueda desenvolverse de manera óptima. Motivo por el cual, se realizará esta investigación para identificar la percepción del desempeño ocupacional de los cuidadores y ver como esto afecta en sus ocupaciones.

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La investigación se realizará en el Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) “Javier Mariátegui Chiappe” del distrito de San Juan de Lurigancho, ubicado en la Av. Lurigancho Cuadra, Mz B Lote 49.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la percepción del desempeño ocupacional de los cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe?

1.4 OBJETIVO

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:

- Identificar la percepción del desempeño ocupacional de cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la influencia del medio ambiente en su desempeño ocupacional de los cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima - 2025.
- Determinar cuan favorable es la percepción del desempeño ocupacional de los cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025.

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación aportará información acerca de la percepción que tienen los cuidadores de su desempeño ocupacional, con la finalidad de prevenir y reconocer las consecuencias que traen consigo este rol de cuidador que asumen con mayor incidencia los familiares.

Además, esta investigación presenta un respaldo teórico, ya que existen diversos estudios relacionados al desempeño ocupacional de cuidadores de personas con diversos diagnósticos, entre los más resaltantes se tiene la investigación de López L y col.(2022) quienes manifestaron que los cuidadores llegan a presentar un desequilibrio ocupacional y el 42% de la muestra manifestaron sobrecarga (9). Para Benavides O y col, los resultados afirman que los cuidadores padecen de sobrecargas leves (18.2%) e intensas (22.2%); de tal modo, tienen ciertas áreas más afectadas, tales como el trabajo, ocio y participación social; esto debido a que la adaptación al rol del cuidador está determinada por el apoyo familiar y tipo de afrontamiento, reflejándose en la calidad de vida y. sobrecarga (10).

Los resultados de la investigación servirán como prevención de sobrecargas generadas al asumir el rol de cuidador y permitir un mejor abordaje mediante el reconocimiento que aportarán un mejor tratamiento oportuno y temprano a los

profesionales del CSMC “Javier Mariategui Chiappe”, porque brindará información valiosa para el conocimiento tanto del paciente como de los profesionales. También, se muestra innovadora porque no hay estudios relacionados en cuidadores de personas con demencia, siendo la salud mental una de las poblaciones que recientemente se ha acrecentado por la pandemia de la COVID19 (11–13).

1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El presente estudio tendrá relevancia debido a la escasez de bases bibliográficas actualizadas (no menor de 5 años). Además, se tendrá un acceso limitado a la población debido a la disponibilidad de horarios para la entrevista, ya que el cuidador cumple diversos roles dentro del hogar.

CAPÍTULO II: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 ANTECEDENTES

INTERNACIONALES

- Gonzalo Luna, (2022)(14). “Perfil ocupacional de los cuidadores familiares” en Zaragoza - España. Se analizó el impacto del cuidado de una persona con discapacidad y/o enfermedad crónica, en el desempeño ocupacional, satisfacción y calidad de vida de la persona que lo cuida; para ello utilizó como instrumento la Valoración Canadiense del Desempeño Ocupacional (COPM). Se trató de un estudio transversal, descriptivo analítico; teniendo como resultado de una muestra de 500 cuidadores, 364 mujeres (72,8%) y 136 hombres (27,2%), (33,6%) suelen ser hijos/as, (76%) tiene pareja y el (75,5%) viven con su familiar que cuidan. Presentaron afectación en las siguientes actividades, descansar y dormir (46.6%), viajar e ir de vacaciones (46,42%), quedar con amigos (39,2), ser puntual y constante en el trabajo (38,2%) y visitar a familiares (34,85%). Finalmente se llegó a la conclusión que el perfil de los cuidadores familiares fue altamente feminizado y presentaron una gran afectación en el desempeño, satisfacción y calidad de vida. También se pudo demostrar que los cuidadores familiares priorizan las actividades de ocio a las de autocuidado y productividad.

- Paredes, Uxía y col. (2022)(9) “Perspectiva ocupacional de personas cuidadoras vinculadas a un centro de personas mayores” España. Tuvieron como objetivo analizar el desempeño ocupacional de las personas cuidadoras que se hacen cargo de personas mayores en situación de dependencia y que acuden a un centro de personas cuidadoras en su entorno natural. Por medio de un estudio mixto utilizaron dos herramientas de evaluación (EuroQol-5D-5L y Sobrecarga de Zarit). Teniendo como resultados que las categorías están asociadas al concepto de persona mayor, la percepción sobre el

cuidador, los apoyos recibidos y el género, el valor del centro de personas mayores, y el rol de cuidador; en cuanto a la calidad de vida, los participantes valoran su estado de salud en una media de 47 y el 42% presenta sobrecarga. Concluyendo que el cuidado diario de personas mayores dependientes supone un desequilibrio ocupacional y sobrecarga en las personas cuidadoras, por ese motivo es importante que los centros de personas mayores puedan aportar beneficios con relación al desempeño ocupacional de las personas cuidadoras, obteniendo resultados positivos en su salud y calidad de vida.

- Oliveira, Elisandreia y col. (2019)(15) “Desempeño ocupacional del paciente, percepción y carga del cuidador anciano en el proceso de demencia”, Brasil. Plantearon como objetivo caracterizar el perfil sociodemográfico de un anciano demente y su cuidador, evaluar el desempeño ocupacional de los ancianos bajo la percepción del cuidador respectivo y el nivel de carga de este cuidador; el método de la investigación fue descriptiva, cualitativa y cuantitativa, donde utilizaron los instrumentos Cuestionario de desempeño del paciente ocupacional y escala de sobrecarga de Zarit, que permitieron encontrar prevalencia general de los cuidadoras informales (88.2%) con sobrecarga severa (52.9%), debido a la atención brindada a los ancianos con demencia, especialmente en relación con las actividades instrumentales de vida diaria, ya que el 88.2% de estos viven con cuidadores familiares. Concluyendo que la necesidad de atención médica y estrategias de intervención con el cuidador informal de pacientes con demencia, con el objetivo de minimizar la carga, mejorar la calidad de vida y prevenir aspectos más agravantes de la enfermedad en estos ancianos y posteriormente de los cuidadores en quienes también se ven afectadas sus áreas de desempeño ocupacional, debido a la sobrecarga presentada por su rol.

- Hijuelos, Nayeli y col. (2018)(16). “Desempeño ocupacional y satisfacción de los cuidadores primarios informales de pacientes con limitación en la actividad”, México. Plantearon determinar la relación existente entre el desempeño y satisfacción ocupacional de los cuidadores primarios informales familiares y el grado de limitación en

la actividad de los pacientes a su cargo; teniendo su metodología es de tipo descriptivo con un diseño transversal. Para ello, se les tomó variables sociodemográficas a 18 cuidadores primarios informales que acudieron a la Unidad Universitaria de Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Yucatán y se les aplicó la Medida Canadiense del Desempeño Ocupacional (MCDO); mientras que a sus respectivos pacientes se les aplicó la Lista de Cotejo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF). Obteniendo que el 83.3% son mujeres, siendo la mayoría madres de los pacientes, amas de casa, casadas y con una escolaridad de nivel licenciatura (50%); en promedio los cuidadores primarios mostraron afectaciones moderadas en el desempeño y satisfacción ocupacional. Por otra parte, el 27.7% presentó una limitación en la actividad grave, también se encontró una correlación negativa entre el nivel de satisfacción de los cuidadores y la limitación en la actividad de los pacientes a su cargo, así como en el desempeño ocupacional. Finalmente concluyeron que, a mayor limitación en la actividad de los pacientes, mayor es la afectación en el nivel del desempeño y satisfacción de los cuidadores primarios informales familiares (16).

- Gómez, María (2017)(17) en su investigación titulada “Relación de la resiliencia y la inteligencia emocional con el desempeño ocupacional y el funcionamiento familiar de los familiares cuidadores de pacientes con demencia de Extramadura – España.” Teniendo como objetivo principal analizar la relación de las variables, es un estudio transversal, analítico y descriptivo, donde se utilizó la escala de Resiliencia Connor-Davidson (CD – RISC), así mismo, la Escala de Funcionamiento Familiar (FACES), escala de inteligencia emocional (TMMS – 24). Teniendo como resultado una variación de acuerdo a la fase en la que se encuentra los enfermos; autocuidado del cuidador en la fase leve del enfermo (3.16%), moderada (3.35%), severa (3.14%). Productividad de cuidadores en la fase leve del enfermo (3.68%), moderada (3.77%), severa (3.7%). Ocio de los cuidadores en la fase leve del enfermo (2.47%), moderada (2.56%) y severa (2.11%). Finalmente, la relación respecto a la fase de la enfermedad es que se halla una relación entre

resiliencia y productividad, esto en la fase severa; por lo cual concluyó que la presencia de mayores niveles de resiliencia en los cuidadores familiares de personas con demencia, se relacionan positivamente con el tiempo empleado al autocuidado y ocio, especialmente en la fase moderada, mientras que en la fase severa de la enfermedad esta relación aparece en la productividad. Los mayores niveles de inteligencia emocional, especialmente desde la reparación emocional, en los cuidadores familiares de personas con demencia, se relacionan positivamente con un mayor tiempo dedicado al autocuidado y al ocio, respecto al funcionamiento familiar, la existencia de mayores de inteligencia emocional.

- **NACIONALES**

No se encontraron antecedente nacionales que contengan los mismos intereses de la investigación, por ese motivo se tomará en cuenta solo antecedentes internacionales ya mencionados.

2.1.2 BASE TEÓRICA

A. DEMENCIA

Para la OMS el término demencia engloba varias enfermedades que se ven afectadas a nivel de la memoria, pensamiento y las capacidades para que la persona desempeñe sus actividades de vida diaria (18). Además, estas enfermedades suelen avanzar con el tiempo y es usual que las personas adultas mayores sean propensas a estas, pero esto no quiere decir que no se presente en una edad temprana (19).

Se trata de enfermedades mentales caracterizadas por trastornos de conducta graves, con juicio distorsionado de la realidad, sin conciencia, cuya sintomatología predominante consiste en un deterioro progresivo del intelecto (4). Es un síndrome que puede deberse a una serie de enfermedades que, con el tiempo, destruyen las células nerviosas y dañan el cerebro, lo que generalmente conduce al deterioro de la función cognitiva (capacidad para procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia habitual del envejecimiento biológico; también se ven afectadas el estado de ánimo, control emocional, comportamiento o motivación (18).

Las consecuencias de la demencia suelen ser físicas, psicológicas, sociales y económicas, no solo para las personas que viven con el síndrome, sino también para sus cuidadores, las familias y la sociedad en general; a menudo hay una falta de concienciación y de comprensión de la demencia, lo que puede causar estigmatización y suponer un obstáculo para el diagnóstico y la atención (18,19).

Mientras que el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM) en su edición V, define la demencia como un trastorno neurocognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos (atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguajes, habilidad perceptual motora o cognición social) que puede estar basado en la preocupación del propio individuo, en un informante que le conoce o en el clínico; este declive en la función cognitiva debe estar preferentemente documentado por un test neuropsicológico estandarizado o, en su defecto, por otra evaluación clínica cuantitativa (20).

Los dominios que se toman en cuenta son:

- Atención compleja (continúa, dividida, selectiva, velocidad de procesado):

Tiene importantes dificultades en entornos con múltiples estímulos (TV, radio, conversaciones); cualquier cosa que suceda en su entorno le distrae fácilmente, es incapaz de atender a menos que los impulsos de entrada sean limitados y simplificados, hay dificultades para retener la información nueva, como recordar números de teléfono o direcciones que le acaban de dar, o explicar lo que se acaba de decir; además, es incapaz de hacer cálculos mentales, interviene más tiempo del habitual en pensar y se le han de simplificar los componentes por procesar a uno o pocos (20).

- Función ejecutiva (planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo, respuesta a la retroalimentación o corrección de errores, inhibición/hábitos predominantes, flexibilidad mental):

Abandona proyectos complejos, tiene que centrar en una tarea cada vez, se fía de otros para planificar las actividades instrumentales de la vida diaria o tomar decisiones (20).

- Aprendizaje o memoria (memoria inmediata, reciente y a muy largo plazo):

Se repite en una conversación, a menudo dentro de la misma conversación, no es capaz de seguir una lista breve de artículos para comprar o de planes para el día y/o necesita recordatorios frecuentes que le orienten en la tarea que está haciendo (20).

- Lenguaje (expresivo y receptivo):

La persona suele utilizar términos generales como “eso” o “ya sabes a lo que me refiero” y prefiere los pronombres personales a los nombres; cuando el trastorno es grave, puede que no recuerde ni los nombres de los amigos íntimos o de la familia, ya que, puede mostrar tanto un uso idiosincrásico de las palabras, como errores gramaticales, lenguaje espontáneo o economía del habla, estereotipia del habla, ecolalia y habla automática, que acostumbran a proceder al mutismo (20).

- Habilidades perceptuales motoras:

Tiene dificultades significativas con actividades que antes le eran familiares (utilizar herramientas, conducir), desenvolverse en entornos familiares, a menudo más confuso en la penumbra, cuando las sombras y la luz escasa alteran la percepción (20).

- Reconocimiento social:

Comportamientos claramente alejados de lo socialmente aceptable, muestra insensibilidad ante las normas sociales de corrección en el vestir o en los temas de conversación políticos, religiosos o sexuales; centrándose excesivamente en un tema a pesar de la falta de interés del grupo o, aunque se lo digan directamente; en tanto a sus intenciones y comportamientos, suelen no tener en cuenta a la familia ni a los amigos; además, toma decisiones sin tener en cuenta la seguridad (por ejemplo, vestimenta inadecuada para el tiempo o la situación social); habitualmente presta poca atención a estos cambios (20).

La demencia puede tener diferentes causas, esto debido a otras enfermedades degenerativas como:

- Enfermedad de Alzheimer
- Degeneración del lóbulo frontotemporal
- Enfermedad por cuerpos de Lewy

- Enfermedad vascular
- Traumatismo cerebral
- Consumo de sustancia o medicamento
- Infección por VIH
- Enfermedad por priones
- Enfermedad de Parkinson
- Enfermedad de Huntington
- Otra afección médica
- Etiologías múltiples

Existen varias clasificaciones de demencia, ya que se trata de alteraciones adquiridas de la memoria y otras habilidades cognitivas, además de cambios en la conducta, pero sobre todo compromete las actividades de vida diaria; según va progresando la disfunción cognitiva se incrementa también el deterioro de funcionalidad, por ello surge la necesidad de clasificar el nivel de severidad y para esta investigación se considerará la Escala de Deterioro Global (GDS), de Reisberg, Barry y col. (1982), la cual trata de una herramienta con 7 estadios de demencia (21).

ETAPAS DE LA DEMENCIA

- FASE 1: GDS 1 (Sin deterioro cognitivo)

Abarcan el funcionamiento cognitivo normal (ausencia de trastorno evidentes); las capacidades funcionales de las personas en los planos ocupacionales, social y en otros marcos permanecen intactas (22).

- FASE 2: GDS 2 (Deterioro cognitivo muy leve)

Describen un funcionamiento cognitivo compatible con la edad; la disminución funcional es subjetiva, pero no objetiva, en el desempeño de actividades ocupacionales o sociales complejas; en esta fase, la persona olvida nombres, lugares donde ha guardado objetos y es menos capaz de recordar citas; los demás no se dan cuenta de los fallos y el funcionamiento ocupacional o social complejo no está comprometido (22).

- FASE 3: GDS 3 (Deterioro cognitivo leve)

Se evidencia una disminución funcional objetiva de suficiente severidad como para interferir en tareas ocupacionales o sociales complejas; la persona por primera vez olvida citas importantes; desde el punto de vista psicomotor, pueden perderse en lugares desconocidos, aunque no tienen dificultades en el desempeño de tareas rutinarias (22).

- FASE 4: GDS 4 (Deterioro cognitivo moderado)

Existe un déficit de realización en el desempeño de tareas complejas de la vida cotidiana; ya que, en esta etapa los pacientes son incapaces de realizar compras de manera eficiente (compran artículos y cantidades incorrectas e inadecuadas; cometen errores de contabilidad importantes por lo que deben de ser supervisados); y el funcionamiento en otras áreas complejas también puede estar comprometido; además, cabe mencionar, que es en esta fase cuando la familia se muestra alarmada por estos fallos y suele llevar al paciente por primera vez al médico (22).

- FASE 5: GDS 5 (Deterioro cognitivo moderado a grave)

Evidencia una realización deficiente de las tareas básicas de la rutina diaria, mostrándose dependiente en el manejo de dinero, realización de compras, elección de ropa adecuada para el tiempo y ocasión, lo que constituye el aspecto patognomónico de esta fase; además, se pone en evidencia errores en la conducción de vehículos (velocidad inadecuada, no respeta señales, incluso puede chocar por primera vez en muchos años); también presentan alteraciones de sueño, emocionales e hiperactividad, siendo consultas médicas frecuentes (22).

- FASE 6: GDS 6 (Deterioro cognitivo grave)

Las capacidades de vestido, control vesical, higiene mayor y menor, disminuyen de manera secuencial (22).

- FASE 7: GDS 7 (Deterioro cognitivo muy grave)

Se trata de la fase terminal; donde hay pérdida de lenguaje, locomoción y conciencia (22).

B. DESEMPEÑO OCUPACIONAL

Este concepto es importante y muy utilizado en el campo de la Terapia Ocupacional, es por ello que se tomará como referencia a dos modelos que permitan definir el desempeño ocupacional.

- Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional (MCDO)

Este modelo tiene origen en el año 1997, gracias al desarrollo que realizó Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT), donde muchos representantes elaboraron directrices sobre la consultoría, la investigación, educación y la práctica; este gran trabajo fue elemental para el desarrollo del MCDO, jugando un papel fundamental en los esfuerzos realizados de la Terapia Ocupacional (23).

El MCDO hace referencia a la relación existente entre la persona, entorno y ocupación; lo cual cambia a lo largo de la vida en respuesta a las oportunidades y desafíos que dan forma al transcurso de la vida ocupacional de cada persona, si estas se ven afectadas, el desempeño de las personas tendría un desequilibrio (24).

Además, Simón Algado y Urbanowski (2006) refiere que el desempeño ocupacional favorece la capacidad de la persona para elegir, organizar y desarrollar de forma satisfactoria ocupaciones significativas y culturalmente adaptadas, en búsqueda del cuidado personal, del disfrute de la vida y contribución a la sociedad, es un proceso dinámico reflejado en la constante interacción de los elementos que la conforman (persona, entorno y ocupación) (24)

- Ocupación: Proviene del concepto general de ocuparse de uno mismo y de ejercer control en la vida propia, incluyendo los ámbitos de autocuidado, ocio y productividad; por lo cual lo vuelve una necesidad humana básica, ya que toda persona debe ocuparse en las diversas facetas de su vida, esto debido a la relación fundamental entre la ocupación y salud (23). Entonces, podemos decir que las ocupaciones le dan significado a la vida cuando llenan y satisfacen un propósito personal y culturalmente importante (24)

- Persona: Hace referencia a seres complejos, integrados por mente, cuerpo y espíritu; siendo la espiritualidad el centro del

MCDO, ya que es vista como la esencia verdadera del ser humano; la mayoría de definiciones se relacionan con una fuerza de vida motivadora, ya que exploran la espiritualidad escuchando a las personas al hablar de sus vidas y reflejar esa realidad en sus ocupaciones; por ese motivo los terapeutas ocupacionales deben buscar la sensibilidad a la realidad espiritual de la persona para que estas reflexionen sobre sus propios valores y creencias, mas no en sus prácticas (24).

- Medio y/o entorno: En este ámbito es importante mencionar que la persona y su desempeño ocupacional jamás se pueden considerar de forma aislada de su medio, ya que los ambientes institucionales, sociales, físicos y culturales poseen una gran influencia en las personas, por ese motivo se deben suponer cada uno de estos aspectos porque intervienen en la función ocupacional de la persona, así como las redes familiares y de amistad, porque inclusive el medio social puede ser el origen o agravar la disfunción ocupacional de la persona (24).

- Equilibrio ocupacional

Existe una relación positiva entre salud y ocupación, de tal manera que la salud de las personas cambia en función de sus ocupaciones a lo largo del tiempo; en Terapia Ocupacional, la salud es vista desde un aspecto más complejo, ya que abarca un desarrollo dinámico de bienestar, cuestiones de dignidad humana, realización del potencial, competencia funcional, una óptima calidad de vida y el hallazgo de significado y satisfacción de vida (25).

Las áreas de desempeño que se ven desde el MCDO son:

- Autocuidado: Teniendo como concepto a la construcción materializada de un conjunto de prácticas que han cumplido una evolución constante y dan una dirección al cuidado de la vida y salud (25).

- Productividad: Es una de las principales áreas de desempeño humano que abarca roles vitales como el sostén del hogar, ama/o de casa, voluntario/a y estudiante; desde la terapia ocupacional se

sostiene el uso del trabajo como medio de evaluación y tratamiento esencial para brindar un sentido de significado y productividad que es vital para la salud, ya que proporciona un sentido de bienestar y contribuye al desarrollo de la autoestima, voluntad, sentimiento de pertenencia y competencia (25).

- Ocio y tiempo libre: Proporciona grandes beneficios que hoy en día las personas no pueden obtener fácilmente desde otros aspectos de su vida, llegando a ser incluso un predictor de la calidad de vida en general; por lo tanto, es fundamental optimizar entre las actividades obligatorias con las actividades de ocio que promueven el compromiso social, bienestar y la calidad de vida, ya que contempla dos aspectos muy importantes; exploración del ocio que permite identificar los intereses, habilidades, oportunidades y actividades; así como la participación del ocio, que mantiene un equilibrio entre las actividades de ocio y otras ocupaciones (25).

- Modelo de la Ocupación Humana (MOHO)

El modelo se centra y/o basa en la ocupación, siendo esta de vital importancia en la experiencia humana, esto debido a la premisa central dada por Kielhofner (2006), donde menciona que toda ocupación procede de una tendencia espontánea, innata del sistema humano, esto debido a la necesidad de explicar y dominar el ambiente; entendiendo que el desempeño ocupacional abarca todas las actividades principales que realizamos con un fin específico (23,26). El MOHO explica el modo en el cual la ocupación adopta patrones, es motivada y realizada, ya que ofrece un punto de vista amplio e integrador; consecuentemente, incorpora tres componentes principales (volición, habituación y la capacidad de desempeño), todo dentro de un ambiente que influye la ocupación, porque considera a la persona bajo un concepto dinámico con dichos componentes (27).

- Volición: Es la capacidad de voluntad y/o elección consciente, guardando relación con el concepto de elecciones ocupacionales, las cuales vienen a ser decisiones cotidianas respecto a las actividades ocupacionales que las personas deciden realizar en un

momento determinado; de esa manera, la persona asume un rol ocupacional que debe desempeñar y a través del cual se emprende un proyecto personal (27). Además, la volición se encuentra conformada por tres componentes:

- Causalidad personal: El sentir propio de vivencia y eficiencia.
- Valores: La razón de ser a lo que considera importante.
- Intereses: Lo que uno disfruta en realizar.
- Habitación: Este componente permite comprender la repetición de patrones familiares de comportamiento y depende de un circuito de tendencias apreciativas organizadas, las cuales permiten al ser humano improvisar modos similares de comportarse en circunstancias similares a lo largo del tiempo, sin deliberación o atención (27). Estos patrones se encuentran guiados por hábitos y roles.
 - Hábitos: Tendencias definidas y adquiridas para responder y desempeñarse de maneras específicas y constantes en ambientes o situaciones conocidas, las cuales dependen de repetir la acción hasta establecerse, así como las circunstancias del medio ambiente.
 - Roles: Posición que uno adopta como su propia responsabilidad y lo realiza por cumplirla.
- Capacidad del desempeño: Conjunto de habilidades que son utilizadas en la elaboración de un comportamiento con propósito y cumple con la organización de los contribuyentes físicos y mentales.

C. CUIDADOR

La importancia del autocuidado en cada persona debe y/o es interiorizado, esto debido a la propia convicción de requerir darse a uno mismo los cuidados adecuados, involucrando un proceso previo y progresivo de acuerdo a las expectativas, carencias, vulnerabilidades, fortalezas y recursos personales; pero cuando esta actividad de vida diaria no se puede desarrollar por alguna

patología, enfermedad y/o diagnóstico, es importante y esencial un miembro presente en la rehabilitación de esta persona, quien es conocido como “cuidador” (25,28).

Al lado de cada persona dependiente y/o que necesita cuidados y atenciones se encuentra un cuidador, con frecuencia no suele ser un profesional, sino un familiar cercano de la persona afectada, quien finalmente asume este rol raramente deseado; si bien es cierto, cuidar es una actividad que muchas personas realizan a lo largo de su vida, pero existen diversos aspectos que hacen esta experiencia sea diferente en cada cuidador (29).

El rol del cuidador suele aparecer repentinamente en la vida de una persona, sin ser elegido y para el cual no se suele estar preparado, es por eso que el cuidador a menudo se encuentra desatendido; por lo tanto, corren el riesgo de adquirir una disminución de la salud y la calidad de vida, lo cual conlleva una afectación en la calidad de atención brindada al paciente (25,28)

Es importante el proceso de adquisición del papel de cuidador, ya que influirá posteriormente a reconocer las funciones que debe cumplir y reconocer cómo se sentirá el propio cuidador llevando a cabo su rol; por ello, existe una clasificación de los tipos de cuidadores:

- Cuidador principal

Es la persona encargada de la mayor parte del cuidado de la persona enferma o que tenga alguna limitación, el cuidador principal suele vivir en el mismo domicilio que el paciente o muy cerca de él y a menudo tiene una relación familiar muy próxima (29,30).

- Cuidador formal

Sujeto con una formación adecuada para cuidar a otra persona que lo requiera, además de recibir una compensación económica por esa labor (29,30).

- Cuidador informal

Forma parte del entorno familiar y colaboran en mayor o menor medida en la atención del entorno (29,30).

Es usual buscar el equilibrio ocupacional en cada uno de los roles que asumimos a lo largo de nuestras vidas, pero a pesar de la naturaleza

ocupacional y la importancia de la identidad ocupacional para una vida saludable, productiva y satisfactoria, no siempre existe una relación positiva entre la ocupación y salud, ya que cuidar a una persona puede tener experiencias positivas, pero también negativas en la salud del cuidador, esto debido a las necesidades que tiene el paciente y al caer toda la responsabilidad en el cuidador, este puede verse inmerso en un proceso de desequilibrio ocupacional entre las áreas de desempeño autocuidado, productividad y ocio (25).

Estas áreas de desempeño ocupacional que debido al rol de cuidador suelen verse afectadas, tiene repercusiones en la salud, ocupación y bienestar, las cuales serán vistas teniendo en cuenta la perspectiva del Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional:

- Autocuidado

Existen muchos estudios que consideran que el nivel de exigencia que demanda el cuidado de una persona dependiente, conlleva anteponer otras necesidades a la de su propio autocuidado, reflejándose por medio de síntomas físicos, psíquicos y de carácter social; además, se comprobaron que la actividad de sueño es una de las cuales se encuentra más afectada en los cuidadores informales (25,31).

- Productividad

El cuidado de una persona dependiente, en muchas ocasiones trae consigo una desorganización en la estructura que maneja la familia, ya que el cuidador es la principal persona que asumirá nuevas tareas, llegando a dedicarse en algunas oportunidades las 24 horas, dependiendo la gravedad del enfermo, por esta razón, dejan de lado su profesión, en caso lo tenga, para esta nueva actividad productiva que no suelen estar preparados y generando así una gran carga económica y/o problemas socio-familiares en el cuidador (25,31,32).

- Ocio y tiempo libre

Debido a las preocupaciones que conlleva cuidar a una persona dependiente, ocurren restricciones por parte del cuidador para asumir su tiempo de ocio, ya que las responsabilidades y obligaciones no solo son a nivel físico, sino que impiden desligar las preocupaciones por

el estado del paciente y de esa manera no goza de un sosiego mental (31,32). La salud del cuidador se ve muy relacionada con la del enfermo a cargo, esto debido al grado de dependencia porque las horas de cuidado se vuelven mayor, llevando a un viaje de soledad y frustración que se afianza paulatinamente con la gravedad progresiva del estado del paciente (25).

2.1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Actividades básicas de vida diaria (ABVD): Se caracterizan por ser universales, estar íntimamente relacionadas a la supervivencia y condición humana (33) .

Actividades de vida diaria (AVD): Son todas aquellas actividades que una persona lleva a cabo diariamente desde que se levanta hasta que se acuesta (34).

Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): Son aquellas actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad que a menudo requieren más interacciones complejas de las utilizadas en las actividades de auto-cuidado utilizadas en las ABVD (35).

Cuidador principal: Es la persona familiar o cercana que se ocupa de brindar de forma prioritaria apoyo físico y emocional a otro, de manera permanente y comprometida (36).

Desempeño ocupacional: Se refiere a la capacidad para ejecutar aquellas tareas que hacen posible desarrollar los roles ocupacionales (37).

Enfermedades degenerativas: Enfermedades en la cual la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo (38).

Equilibrio ocupacional: Percepción o experiencia subjetiva que tiene el propio individuo acerca de tener la cantidad adecuada de ocupaciones, la correcta variación entre las mismas y la satisfacción con el tiempo dedicado (39).

Habitación: Es la forma que hemos aprendido a ser en nuestros contextos donde nos desenvolvemos (24).

Hiperactividad: Existe mayor movimiento, acciones impulsivas, un periodo de atención más corto y la persona suele distraerse fácilmente (40).

Idiosincrático: Palabras con significado inusual, son peculiares y fuera de lugar en una conversación ordinaria (41).

Neurocognitivo: Relacionado con la capacidad de pensar y razonar, incluyendo la capacidad de concentrarse, recordar, procesar información, aprender, hablar y entender (42).

Neuropsicológico: La relación del cerebro y la conducta tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral (43).

Patognomónico: Hallazgos distintivos o característicos de una enfermedad o afección determinada que se pueden usar para establecer un diagnóstico (44).

Patrones de desempeño: Hace referencia a los hábitos, rutinas y roles que adopta un individuo en la medida que desarrolla ocupaciones o actividades de la vida diaria (45).

Productividad: Actividades significativas para el desarrollo personal, contribución social y calidad de vida (46).

Psicomotor: Adquisición de habilidades durante la etapa de la infancia, es decir, proceso mediante el cual el niño aprender a moverse, hablar o distinguir personas y objetos, entre otras capacidades (47).

Rol ocupacional: Aquellos que se desarrollan dentro de la sociedad (48).
Sobrecarga del cuidador: Refiere a las dificultades financieras, psicosociales que resultan cuidar a un miembro de la familia que padece una condición médica (49).

Terapia Ocupacional: Carrera profesional que tiene como uso terapéutico las actividades de cuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad, puede incluir la adaptación de tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia y aumentar la calidad de vida (23).

Volición: Hace referencia al acto de voluntad, capacidad propia de los seres humanos (27).

2.1.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

H₁: La percepción del desempeño ocupacional en cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025 es favorable.

H₀: La percepción del desempeño ocupacional en cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025 es desfavorable.

2.1.5 VARIABLES, OPERALIZACIÓN

Las variables se operalizarán de acuerdo con las tablas que son presentadas a continuación:

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	TIPO DE VARIABLE	ESCALA DE MEDICIÓN	DIMENSIONES	INDICADORES	VALORES	INSTRUMENTO
DESEMPEÑO OCUPACIONAL	Se concibe como el resultado de una relación dinámica entre personas, entorno y ocupación a lo largo de la vida del sujeto y cualquier cambio en cualquier parte de la interacción entre el sujeto, entorno y ocupación afecta a las otras partes y en consecuencia al desempeño (Kielhofner, 2006) (27).	Existe una relación entre la persona, el medio y las ocupaciones. La persona está conectada con el medio, de esta interacción nace la ocupación. Es aplicado tanto a personas como a grupos o comunidades.	CUANTITATIVA	ORDINAL	DESEMPEÑO	DESTREZAS (1,3,4,5,6,7,8)	1: Gran problema 2: Un poco difícil 3: Bien 4: Sumamente bien 1: No tan importante 2: Importante 3: Muy importante 4: Sumamente importante	Cuestionario del Desempeño ocupacional de la Autoevaluación Ocupacional (OSA)
						HABILIDADES (2,9,10,11)		
					HABITUACIÓN	HÁBITOS (12 al 15)		
						ROLES (16)		
					VOLICIÓN	CAUSALIDAD (18,20,21)		
						VALORES (19)		
						INTERESES (17)		
					AMBIENTE	FÍSICOS (22 al 25)		
						SOCIAL (26 al 29)		

2.2 DISEÑO METODOLÓGICO

2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según Hernandez Sampieri, en su guía “Metodología de investigación” sexta edición (2014), este proyecto utilizará el enfoque cuantitativo, puesto que los resultados serán analizados estadísticamente, con un alcance descriptivo. El diseño será no experimental, ya que solo se observarán los fenómenos en su ambiente natural para ser analizados; con corte transversal debido que la recolección de datos será en un solo momento y tendrá una proyección prospectiva porque la investigación se tomará en un tiempo determinado y los resultados se darán a futuro (50).

2.2.2 POBLACIÓN

Teniendo en cuenta la definición de Fracica (1998), población, es el “conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación” y para Lepkowski (2008), como “conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”.

Tales definiciones nos llevan a determinar la población de esta investigación, la cual estará constituida por 109 cuidadores hombres y mujeres de personas con demencia en el Centro de Salud Mental Comunitario – Javier Mariátegui Chiappe.

2.2.3 MUESTRA Y MUESTREO

Los integrantes de la muestra deberán cumplir los criterios de inclusión y exclusión.

El muestreo será no probabilístico por conveniencia, ya que solo serán conformados por aquellos que convienen para esta investigación, esto en concordancia con lo que sostiene Hernandez Sampieri, donde menciona que el muestreo no probabilístico será constituido por aquellos que no dependen de una probabilidad sino por decisiones del investigador (50).

2.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Cuidadores de personas con demencia del CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025.
- Personas que desempeñan el rol de cuidador como mínimo un año.
- Cuidadores principales (persona familiar o cercana que se ocupa de brindar de forma prioritaria apoyo físico y emocional a otro, de manera permanente y comprometida)
- Cuidadores entre 18 y 60 años
- Cuidadores que aceptan su participación en la investigación mediante el consentimiento informado

2.2.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Cuidadores de más de una persona a su cargo
- Cuidadores de personas con discapacidad motora

2.2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Según Bunge (1979), el método científico refiere un conjunto de procedimientos, que valiéndose de instrumentos y/o técnicas necesarias, se encargan de medir, examinar y solucionar un problema o varios de investigación (51).

El presente proyecto usa como técnica de recolección de datos, donde se realizará una entrevista con el cuidador y se aplicará la encuesta de Auto-evaluación Ocupacional (OSA) como instrumento, basado en el Modelo de la Ocupación Humana (Kielhofner 2004) el cual provee la base teórica en la que se forma el contexto de los ítems del OSA; y el Modelo Canadiense de la práctica centrada en el cliente proporciona el marco para el uso del OSA; Además, se trata de una evaluación multidimensional, los cuales permitirán medir el Desempeño Ocupacional, de la cual se obtendrá la percepción personal en su propia función ocupacional (52,53).

El OSA consta de un conjunto de ítems que la Terapia Ocupacional puede abordar, conteniendo un total 29 ítems (21 relacionados con sí mismos y 8 con el ambiente); los primeros 21 ítems, habla de uno mismo, donde el participante valora su nivel de competencia y posteriormente se debe valorar la importancia que cada ítem representa para ellos; mientras que la segunda parte con 8 ítems, habla del ambiente, en el que se valoran los ambientes físico y social en el que se desenvuelve, primero se autoevalúan y después se determina qué tan importante es para la persona (52).

La OSA fue revisada en distintos estudios que confirmaron que “el autoinforme tiene buena validez interna, es suficientemente sensible y confiable para distinguir entre los niveles de personas, y puede ser utilizado de manera confiable por la gran mayoría de los participantes”. Además, “la OSA puede ser utilizada por individuos con una variedad de contextos personales, sociales, culturales y ambientales para evaluar la competencia ocupacional de un individuo y su valor para el desempeño y participación ocupacional”. Así es como se demuestra que este instrumento posee una “validez social al aplicarse en todos los países de habla hispana, por lo que es útil al evaluar poblaciones con distintas características”(52).

MI MISMO				MI AMBIENTE			
No favorable		Favorable		No favorable		Favorable	
Gran problema (0 – 21)	Un poco difícil (22 – 42)	Bien (43 – 63)	Sumamente bien (64 – 84)	Gran problema (0 – 21)	Un poco difícil (22 – 42)	Bien (43 – 63)	Sumamente bien (64 – 84)
(0 – 42)		(43 – 84)		(0 – 42)		(43 – 84)	

2.2.7 PLAN DE RECOLECCIÓN

Se solicitará la autorización al Centro de Salud Mental Comunitario Javier Mariategui Chiappe para la aplicación del instrumento a la población del presente estudio.

Luego se determinará un listado de pacientes con el diagnóstico de demencia, los cuales permitirá identificar a los cuidadores de dichos pacientes, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.

Se solicitará al área de Recursos Humanos los datos de los pacientes y/o apoderados para poder contactar con el cuidador, por medio de llamadas o mensajes de texto/WhatsApp; una vez reconocidos se les brindará el consentimiento informado para su participación en la investigación, haciendo uso del OSA.

Finalmente, para la determinación de respuestas recolectadas se utilizará Excel y el programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), para estructurar, ordenar y analizar los diferentes resultados obtenidos en tablas y cuadros.

2.2.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

El análisis estadístico se diseña para evaluar el grado al cual la evidencia de las medidas recogidas apoya la existencia de ese patrón (50). Por eso, para esta investigación se utilizará el SPSS, el cual permitirá crear tablas y gráficas de data compleja, para su correspondiente interpretación considerando el marco teórico y el análisis estadístico correspondiente.

2.2.9 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

El instrumento que se utilizará en la presente investigación ha demostrado tener buena validez y fiabilidad para evaluar la percepción de la competencia ocupacional y la importancia de las actividades en individuos, especialmente útil en la terapia ocupacional (54). Los estudios han mostrado que la OSA mide consistentemente los mismos constructos a lo largo del tiempo y puede detectar cambios significativos en la percepción del usuario (54).

Además, cuenta con una validez de contenido, los ítems de la OSA están diseñados para capturar los constructos de competencia y valor ocupacional, y la progresión de los ítems muestra una progresión significativa que se ha mantenido estable en diferentes estudios (55,56). Validez de constructo, porque se basa en el Modelo de Ocupación Humana y evalúa la percepción del usuario sobre su competencia y el valor que otorga a diferentes actividades. Finalmente, la validez de criterio, ya que es capaz de detectar cambios en la percepción de los

usuarios sobre su competencia y valor ocupacional, lo que indica su capacidad para medir resultados (57).

El coeficiente alfa fue descrito en 1951 por Lee J. Cronbach. Se trata de un índice utilizado para medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. Además, el coeficiente alfa de Cronbach es una formula general para estimar la confiabilidad de un instrumento en la que las respuestas de los ítems son dicotómicas o tiene más de dos valores, por esa razón se utilizará dicha prueba debido a que la OSA permite respuestas múltiples (58).

En tanto a la confiabilidad de la OSA, los estudios han mostrado que sus ítems son coherentes en la medición de los constructos de competencia y valor, permitiendo tener una consistencia interna. También ha demostrado ser estable a lo largo del tiempo con los ítems, manteniendo su estructura y los usuarios calificándolos de manera consistente, lo cual indica una estabilidad temporal; por último, la fiabilidad de separación de ítems, que indica la capacidad de las escalas para diferenciar entre diferentes niveles de competencia y valor, ha sido satisfactoria en estudios de la OSA (59,60) .

2.2.10 COSIDERACIONES ÉTICAS

Para el estudio se considerará los “Principios éticos de Helsinki, promulgado en 1964 y actualizado en el 2013 por la Asociación Médico Mundial (AMM)” que establece proteger la dignidad, autonomía, privacidad y confidencialidad de los participantes en esta investigación (61).

En el presente trabajo se respetará la originalidad de la literatura científica utilizada, citando adecuadamente los autores, verificando que en cada artículo también se cumpla los debidos aspectos éticos.

Se asegurará total confidencialidad sobre los datos de los cuidadores que decidan participar voluntariamente en la investigación a través del

consentimiento informado, estableciendo que no existe ningún tipo de riesgo en su participación.

CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES	2024										
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
1. Elección del tema											
2. Búsqueda de bibliografía											
3. Planteamiento del problema											
4. Elaboración de objetivos											
5. Bases teóricas, marco conceptual											
6. Variables y Operacionalización											
7. Diseño metodológico											
8. Cronograma de trabajo											
9. Presupuesto y financiamiento											
10. Recursos disponibles											

11. Juicio de expertos											
12. Prueba piloto											
13. Sustentación											

3.2 PRESUPUESTO

- BIENES

RECURSOS	COSTOS	CANTIDAD	TOTAL
Copias	S/ 0.05	400	S/ 20.00
Lapiceros	S/ 1.00	100	S/ 100.00
Folder	S/ 10.00	1	S/ 10.00
Laptop	S/ 3500.00	1	S/ 3500.00
IMPRESORA			
TINTA, ETC			
TOTAL			S/ 3630.00

- SERVICIOS

SERVICIOS	MONTO
Electricidad	S/ 50.00
Internet	S/ 100.00
Estadista	1000.00
Asesor	S/ 0.00
TOTAL	S/1150.00

COSTO TOTAL

	SUBTOTAL
--	-----------------

BIENES	S/ 3630.00
SERVICIOS	S/ 1150.00
TOTAL	S/ 4780.00

3.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Este proyecto de investigación es autofinanciado, a excepción del asesor, ya que es brindado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

3.4 RECURSOS DISPONIBLES

- RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD	DEFINICION
Asesora del proyecto de tesis: Dra. Mery Joachin del Carpio	1	
Investigadora: Bach: Kelly Rodriguez Arostegui	1	

- RECURSOS MATERIALES

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD	
Laptop	1	
Escritorio	1	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. [citado 24 de octubre de 2023]. No hay salud sin salud mental. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/8-10-2020-no-hay-salud-sin-salud-mental>
2. Caribe CE para AL y el. Acerca de Envejecimiento [Internet]. Comisión Económica para América Latina y el Caribe; [citado 10 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/temas/envejecimiento/acerca-envejecimiento>
3. Enfermedades no transmisibles - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 23 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles>
4. Amarista FJ. Demencia. Gac Médica Caracas [Internet]. julio de 2002 [citado 29 de mayo de 2024];110(3):310-7. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0367-47622002000300003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
5. Demencia [Internet]. [citado 15 de marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
6. Pérez Rodríguez M, y col. El síndrome del cuidador en cuidadores principales de ancianos con demencia Alzheimer. Gac Médica Espirituana [Internet]. abril de 2017 [citado 6 de noviembre de 2021];19(1):38-50. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1608-89212017000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
7. World Alzheimer Report 2022: Life after diagnosis: Navigating treatment, care and support. 21 de septiembre de 2022 [citado 23 de octubre de 2023]; Disponible en: <https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2022/>
8. Custodio N. Vivir con demencia en Perú: ¿El sistema de salud está enfrentando la sobrecarga? Rev Neuro-Psiquiatr [Internet]. enero de 2016 [citado 10 de diciembre de 2021];79(1):1-2. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-85972016000100001&lng=es&nrm=iso&tlng=es
9. Maseda UP, Miranda-Duro* M del C, Rodríguez LL. Perspectiva ocupacional de personas cuidadoras vinculadas a un centro de personas mayores. Estudio mixto: Rev Ter Ocupacional Galicia [Internet]. 31 de mayo de 2022 [citado 23 de mayo de 2024];19(1):13-20. Disponible en: <https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/162>
10. Benavides O, Albuquerque D, Chaná-Cuevas P. Evaluación de la sobrecarga en los cuidadores de los pacientes con enfermedad de Parkinson ambulatorios y sus factores de riesgo. Rev Médica Chile [Internet]. marzo de 2013 [citado 11 de julio de 2024];141(3):320-6. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-98872013000300006&lng=es&nrm=iso&tlng=es

11. Huarcaya-Victoria J. Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. Rev Peru Med Exp Salud Pública [Internet]. 21 de abril de 2020 [citado 23 de mayo de 2024];37(2):327-34. Disponible en: <https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/5419>
12. Boletín Desastres N.131.- Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de la población - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 23 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/boletin-desastres-n131-impacto-pandemia-covid-19-salud-mental-poblacion>
13. COVID-19 pandemic triggers 25% increase in prevalence of anxiety and depression worldwide [Internet]. [citado 23 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide>
14. Gonzalo Ciria Laura. Perfil ocupacional de los cuidadores familiares [Internet] [Tesis Doctoral]. [España]: Universidad de Zaragoza; 2022. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=318300>
15. Frizoni EO, Bianchin MA, Tognola WA. Desempenho ocupacional do paciente, percepção e sobrecarga do cuidador de idoso no processo demencial. Rev Kairós-Gerontol [Internet]. 30 de junio de 2019 [citado 12 de julio de 2024];22(2):213-29. Disponible en: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/45649>
16. Hijuelos García Nayeli Alejandra, y col. Desempeño ocupacional y satisfacción de los cuidadores primarios informales de pacientes con limitación en la actividad. Rev Iberoam Las Cienc Salud [Internet]. 2018;7(13):32. Disponible en: <https://www.rics.org.mx/index.php/RICS/article/view/58>
17. Gómez Trinidad MN. Relación de la resiliencia y la inteligencia emocional con el desempeño ocupacional y el funcionamiento familiar de los familiares cuidadores de pacientes con demencia de Extremadura [Internet] [doctoralThesis]. 2017 [citado 24 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://dehesa.unex.es:8443/handle/10662/5550>
18. Demencia [Internet]. [citado 29 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
19. Demencia - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2022 [citado 29 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/demencia>
20. Pontificia Universidad Católica de Chile. Epidemiología, diagnóstico y pruebas cognitivas de demencias en APS [Internet]. Escuela de Medicina. [citado 9 de febrero de 2024]. Disponible en: <https://medicina.uc.cl/publicacion/epidemiologia-diagnostico-y-pruebas-cognitivas-de-demencias-en-aps/>
21. Reisberg B, Ferris S. SCRIBD. 2019 [citado 30 de mayo de 2024]. Escala GDS | PDF | Memoria | Ansiedad. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/420960959/Escala-GDS>
22. Escobar VB, Marietta V. Programa virtual de estimulación cognitiva para adultos mayores de lima con educación superior y sin diagnóstico de demencia. 2020-2021. Repos Inst - USS [Internet]. 2022 [citado 30 de mayo de 2024]; Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3352978>

23. Boyt Schell BA, Guillen G, Scaffa ME, Cohn ES. Wiillard y Spackman: Terapia Ocupacional. 12ª. Médica Panamericana; 2015. 1264 p.
24. Simó Algado S, Urbanowski R. El modelo canadiense del proceso del desempeño ocupacional. Rev Electrónica Ter Ocupacional Galicia TOG [Internet]. 2006 [citado 23 de octubre de 2023];(3):6. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1456301>
25. Ciria LG. Perfil ocupacional de los cuidadores familiares. Univ Zaragoza [Internet]. 7 de febrero de 2021;337. Disponible en: <https://zaguan.unizar.es/record/118104/files/TESIS-2022-151.pdf>
26. Kielhofner G. Terapia ocupacional. Modelo de Ocupación Humana. Teoría y aplicación. Ed. Médica Panamericana; 2004. 664 p.
27. Kielhofner G. Modelo de ocupación humana: teoría y aplicación: 4a edición. Médica Panamericana; 2011. 566 p.
28. Wang TS y D. Caregiver Lifestyle Intervention Program: Promoting Better Self-Care | AOTA [Internet]. 2019 [citado 17 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.aota.org/publications/ot-practice/ot-practice-issues/2019/caregiver-intervention>
29. Cruz Rivas Herrera J, Ostiguín Meléndez RM. Cuidador: ¿concepto operativo o preludio teórico? Enferm Univ [Internet]. marzo de 2011 [citado 10 de diciembre de 2021];8(1):49-54. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1665-70632011000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
30. Plácido Oscco ML. Nivel de sobrecarga y estrategias de afrontamiento en cuidador principal de pacientes con esquizofrenia de un hospital de Lima, 2020. Univ Priv Norbert Wien - Wien [Internet]. 11 de octubre de 2020 [citado 17 de junio de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/4340>
31. Toledo ÁM. Repercusión de la enfermedad de Alzheimer en el núcleo familiar. Poiésis [Internet]. 2008 [citado 18 de junio de 2024];(16). Disponible en: <https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/poiesis/article/view/248>
32. López Gil MJ, Orueta Sánchez R, Gómez-Caro S, Sánchez Oropesa A, Carmona de la Morena J, Alonso Moreno FJ. El rol de Cuidador de personas dependientes y sus repercusiones sobre su Calidad de Vida y su Salud. Rev Clínica Med Fam [Internet]. junio de 2009 [citado 18 de junio de 2024];2(7):332-9. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1699-695X2009000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
33. Manava Alzheimer - Centro de Día y Terapia para demencias en distintas fases [Internet]. 2015 [citado 11 de julio de 2024]. Actividades básicas de la vida diaria y terapia ocupacional. Disponible en: <https://www.manava.es/blog/actividades-basicas-de-la-vida-diaria-terapia-ocupacional/>
34. Terapia ocupacional a domicilio: qué es y cómo se trabaja [Internet]. 2022 [citado 11 de julio de 2024]. Disponible en: <https://neuronup.com/estimulacion-y-rehabilitacion-cognitiva/terapia-ocupacional/terapia-ocupacional-a-domicilio-que-es-y-como-se-trabaja/>

35. Programa de entrenamiento de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria - Grupo Albertia [Internet]. [citado 11 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.albertia.es/programa-de-entrenamiento-de-actividades-instrumentales-de-la-vida-diaria/>
36. Venegas Bustos BC. Habilidad del cuidador y funcionalidad de la persona cuidada. Aquichan [Internet]. octubre de 2006 [citado 11 de julio de 2024];6(1):137-47. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1657-59972006000100013&lng=en&nrm=iso&tlng=es
37. Universidad de Pamplona [Internet]. 2015 [citado 11 de julio de 2024]. Modelo de Desempeño Ocupacional. Disponible en: <https://enfoquesto.wixsite.com/unipamplona2015/blank-iujti>
38. Definición de enfermedad degenerativa - Diccionario de cáncer del NCI - NCI [Internet]. 2011 [citado 11 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/enfermedad-degenerativa>
39. Martín AS, Roig SL, Gómez PP. Concepto de equilibrio ocupacional en estudiantes de 1º de grado de Terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. 2017;14(26):9. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6273869>
40. Hiperactividad: MedlinePlus enciclopedia médica [Internet]. [citado 12 de julio de 2024]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003256.htm>
41. Aproximación al lenguaje en el trastorno del espectro autista - Fundación Orienta [Internet]. [citado 12 de julio de 2024]. Disponible en: <https://www.fundacioorienta.com/es/aproximacion-al-lenguaje-en-el-trastorno-del-espectro-autista/>
42. Funciones cognitivas, definición, clasificación e intervención [Internet]. [citado 12 de julio de 2024]. Disponible en: <https://neuronup.com/areas-de-intervencion/funciones-cognitivas/>
43. Julipi C. ¿Qué es la Neuropsicología? [Internet]. Blog de Psicología del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. 2019 [citado 12 de julio de 2024]. Disponible en: [://blogpsicologia.cohttpspmadrid.org/que-es-la-neuropsicologia/](http://blogpsicologia.cohttpspmadrid.org/que-es-la-neuropsicologia/)
44. Clínica U. Navarra. <https://www.cun.es>. [citado 12 de julio de 2024]. Qué es Patognomónico. Disponible en: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/patognomiconico>
45. AOTA. Marco de trabajo para la práctica de la terapia ocupacional: Dominio y proceso [Internet]. 2020 [citado 25 de julio de 2024]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/slideshow/aota-2020-espaol-revisada-y-corregida/249957225>
46. Cequea M, Monroy C, Nuñez M. La productividad desde una perspectiva humana: Dimensiones y factores. Univ Politécnica Madr [Internet]. 2011;36. Disponible en: <https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11316/marvel%20cequea.pdf>
47. SEFHOR. ¿Qué es el Desarrollo Psicomotor y cuáles son sus Fases? [Internet]. SEFHOR. 2020 [citado 12 de julio de 2024]. Disponible en: <https://sefhor.com/desarrollo-psicomotor/>

48. Prada M, y col. El desempeño de los roles ocupacionales y su relación con las actividades instrumentales de la vida diaria en los jóvenes. Disponible en: <https://www.aacademica.org/000-054/895.pdf>
49. Salas-Delgado A, Peschard-Sáenz E, Martinez-Moreno A. Sobrecarga del cuidador principal como factor de riesgo para caídas en pacientes geriátricos. Salud Pública México [Internet]. junio de 2015 [citado 12 de julio de 2024];57(3):198-9. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0036-36342015000300006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
50. Hernández Sampieri Roberto, y col. Metodología de la investigación [Internet]. Sexta. Mexico: McGRAW-HILL; 2014. 736 p. Disponible en: <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
51. Bernal CA. Metodología de la investigación [Internet]. Tercera. Colombia: Pearson; 2010. 320 p. Disponible en: <https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf>
52. Baron K, Kielhofner G, Iyenger A, Goldhammer V, Wolenski J. A User's Manual for the Occupational Self Assessment (OSA): (Version 2.2). Chicago: University of Illinois : Model of Human Occupation Clearinghouse. Dept. of Occupational Therapy; 2006. 67 p. (User's Manual for).
53. Modelo de Ocupación Humana [Internet]. 2015 [citado 21 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.sintesis.com/libro/modelo-de-ocupacion-humana>
54. Taylor R, Lee SW, Kramer J, Shirashi Y, Kielhofner G. Psychometric Study of the Occupational Self Assessment with Adolescents After Infectious Mononucleosis. Am J Occup Ther Off Publ Am Occup Ther Assoc [Internet]. 2011 [citado 5 de agosto de 2025];65(2):e20-8. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3302424/>
55. Méndez Martínez M. Procedimiento operativo estandarizado. Autoevaluación ocupacional. 11 de abril de 2024 [citado 5 de agosto de 2025]; Disponible en: <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/42839>
56. Autoevaluación ocupacional | Base de datos RehabMeasures [Internet]. 2018 [citado 5 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/occupational-self-assessment>
57. (PDF) La autoevaluación ocupacional: estabilidad y capacidad para detectar cambios a lo largo del tiempo [Internet]. [citado 5 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/246797088_The_Occupational_Self_Assessment_Stability_and_the_Ability_to_Detect_Change_Over_Time
58. Oviedo HC, Campo-Arias A. Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. Rev Colomb Psiquiatr [Internet]. diciembre de 2005 [citado 12 de julio de 2024];34(4):572-80. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-74502005000400009&lng=en&nrm=iso&tlng=es

59. Pan AW, Chung L, Chen TJ, Hsiung PC. The study of the validity and reliability of the Occupational Self-Assessment-traditional Chinese version. Hong Kong J Occup Ther HKJOT [Internet]. junio de 2020 [citado 5 de agosto de 2025];33(1):18-24. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8008370/>
60. Popova ES, Ostrowski RK, Wescott JJ, Taylor RR. Development and Validation of the Occupational Self-Assessment–Short Form (OSA–SF). Am J Occup Ther [Internet]. 26 de abril de 2019 [citado 5 de agosto de 2025];73(3):7303205020p1-10. Disponible en: <https://doi.org/10.5014/ajot.2019.030288>
61. WMA - The World Medical Association-Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos [Internet]. [citado 21 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.wma.net/es/policias-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>

ANEXOS

Anexo 1: Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

“Percepción del desempeño ocupacional en cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, SJL – 2025”

Investigador: Kelly Rodriguez Arostegui

Propósito del Estudio:

Se le invita a participar en un estudio desarrollado con la finalidad de Conocer la percepción del desempeño ocupacional de cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, SJL – 2025.

Participación: Si usted acepta participar en este estudio se requerirán algunos datos epidemiológicos (edad, sexo). Se aplicará un cuestionario para medir la percepción del desempeño ocupacional.

Riesgos: No se prevén riesgos para su salud derivados de la participación en el estudio, puesto que el recojo de la información necesaria se realizará mediante una ficha de recolección de datos.

Beneficios: El pertenecer al estudio no producirá beneficio económico, pero se beneficiará la institución, pues se obtendrán resultados que permitirán implementar las mejoras correspondientes.

Confidencialidad: Guardaremos la información obtenida mediante códigos y no con nombres. Si los resultados de esta investigación son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

Información: Para cualquier consulta, queja o comentario por favor comunicarse al correo: kelly.rodriguez2@unmsm.edu.pe

Derechos del participante: Si usted acepta participar en este estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno.

DECLARACIÓN VOLUNTARIA

He leído y comprendido toda la información precedente que describe las características de este estudio, todas mis preguntas y dudas han sido satisfechas. Yo doy voluntariamente mi consentimiento para participar en este estudio; entiendo que soy libre de participar en el estudio o poder retirarme en cualquier momento sin que ello me ocasione perjuicio alguno.

Nombre del participante:

DNI:

Fecha:

Firma:

Anexo 2:

Solicitud al Centro de Salud Mental Comunitario “Javier Mariátegui Chiappe”

Solicito: Autorización para realizar trabajo de investigación (Nómina de pacientes con demencia y relación de los apoderados y/o familiares)

Señora Directora del CSMC “Javier Mariátegui Chiappe”:

Yo, Kelly Rodriguez Arostegui, estudiante del Área de Terapia ocupacional de la escuela profesional de Tecnología médica de la facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, identificado con el DNI N°75435705. Ante Ud. Respetuosamente me presento y expongo:

Es imprescindible realizar estudios sobre la percepción del desempeño ocupacional de cuidadores de personas con demencia, de tal manera lograr identificarlos para lograr beneficios en este tipo de población que muchas veces se ven afectadas. Solicito ante usted la autorización para realizar mi trabajo de investigación de manera presencial, para contactar con los cuidadores de pacientes con diagnóstico de demencia, en quienes se aplicará la Auto-evaluación ocupacional (OSA), permitiendo el resultado de estas, información a su despacho y a los cuidadores que deseen participar en la investigación.

Por lo expuesto:

Ruego a usted acceder a mi solicitud, por ser de justicia que espero alcanzar.

Lima 13 de Julio del 2024.

Kelly Rodriguez Arostegui
DNI 75435705

Anexo 3: Instrumento

AUTOEVALUACIÓN OCUPACIONAL (OSA)

Auto-evaluación Ocupacional Mi Mismo

Nombre: _____

Fecha: _____

Paso 1: Abajo hay afirmaciones acerca de las cosas que hace en su vida diaria. Para cada afirmación, marque con un círculo cuan bien lo hace. Si algún ítem no corresponde a su realidad, márkelo y pase al ítem siguiente.					Paso 2: Ahora, para cada afirmación marque con un círculo cuan importante es para usted.				Paso 3: Elija 4 aspectos de usted mismo que le gustaría cambiar
	Hacer esto es un gran problema para mí	Hacer esto es un poco difícil para mí	Esto lo hago bien	Esto lo hago sumamente bien	Esto no es tan importante para mí	Esto es importante para mí	Esto es muy importante para mí	Esto es sumamente importante para mí	Me gustaría cambiar...
Concentrarme en mis tareas.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Hacer físicamente lo que necesito hacer.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Cuidar el lugar donde vivo.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Cuidar de mi mismo.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Cuidar de otros de quienes soy responsable.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Llegar donde necesito ir.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Manejar mis finanzas.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Manejar mis necesidades básicas (alimentación, medicación)	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Expresarme con otros.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Llevarme bien con otros.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	

Paso 1: Abajo hay afirmaciones acerca de las cosas que hace en su vida diaria. Para cada afirmación, marque con un círculo cuan bien lo hace. Si algún ítem no corresponde a su realidad, márkelo y pase al ítem siguiente.					Paso 2: Ahora, para cada afirmación marque con un círculo cuan importante es para usted.				Paso 3: Elija 4 aspectos de usted mismo que le gustaría cambiar
	Hacer esto es un gran problema para mí	Hacer esto es un poco difícil para mí	Esto lo hago bien	Esto lo hago sumamente bien	Esto no es tan importante para mí	Esto es importante para mí	Esto es muy importante para mí	Esto es sumamente importante para mí	Me gustaría cambiar...
Identificar y resolver problemas.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Relajarme y disfrutar.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Completar lo que necesito hacer.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Tener una rutina satisfactoria.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Manejar mis responsabilidades.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Participar como estudiante, trabajador, voluntario, miembro de familia, otros.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Hacer las actividades que me gustan.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Trabajar con respecto a mis objetivos.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Tomar decisiones basadas en lo que pienso que es importante.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Llevar a cabo lo que planifico hacer.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Usar con eficacia mis habilidades.	gran problema	un poco difícil	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	

Auto-evaluación Ocupacional Mi Ambiente

Nota: Esta sección se puede utilizar como información general, no para investigación. Actualmente existen otros instrumentos que reportan mayor validez acerca del impacto ambiental.

Nombre: _____

Fecha: _____

Paso 1: Debajo hay afirmaciones acerca de su ambiente (donde vive, trabaja, va a la escuela, etc.). Para cada afirmación marque con un círculo que represente cómo es este aspecto para usted. Si un ítem no corresponde a su realidad, márkelo y pase al siguiente.					Paso 2: Ahora, para cada afirmación marque con un círculo cuan importante es este aspecto del ambiente para usted.				Paso 3: Elija 1 o 2 aspectos que le gustaría cambiar.
	Esto es un gran problema para mí	Esto es un problema para mí	Esto está bien	Esto es sumamente bien	Esto no es tan importante para mí	Esto es importante para mí	Esto es muy importante para mí	Esto es sumamente importante para mí	Me gustaría cambiar...
El lugar para vivir y cuidar de mí mismo.	gran problema	problema	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
El lugar donde soy productivo (trabajar, estudiar, voluntario).	gran problema	problema	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Las cosas básicas que necesito para vivir y cuidar de mí mismo.	gran problema	problema	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Las cosas que necesito para ser productivo.	gran problema	problema	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Las personas que me apoyan y me alientan	gran problema	problema	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Las personas que hacen cosas conmigo.	gran problema	problema	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Las oportunidades de hacer cosas que valoro y me gustan.	gran problema	problema	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	
Los lugares donde puedo ir y disfrutar.	gran problema	problema	bien	sumamente bien	no tan importante	importante	muy importante	sumamente importante	

[https://search.worldcat.org/es/title/A-User's-Manual-for-the-Occupational-Self-Assessment-\(OSA\)-:\(Version-2.2\)/oclc/4755476](https://search.worldcat.org/es/title/A-User's-Manual-for-the-Occupational-Self-Assessment-(OSA)-:(Version-2.2)/oclc/4755476)

Anexo 4: Matriz de consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	METODOLOGÍA
¿Cuál es la percepción de los cuidadores de personas con demencia sobre su desempeño ocupacional en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe?	General: Identificar la percepción del desempeño ocupacional de cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025 Específicos: - Determinar la influencia del medio ambiente en su desempeño ocupacional de los cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima - 2025. - Determinar cuan favorable es la percepción del desempeño ocupacional de los cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025.	H₁: La percepción del desempeño ocupacional en cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025 es favorable. H₀: La percepción del desempeño ocupacional en cuidadores de personas con demencia en el CSMC Javier Mariátegui Chiappe, Lima – 2025 es desfavorable.	Desempeño ocupacional	Desempeño	Tipo de investigación: Cuantitativa Diseño de investigación: No experimental Descriptivo transversal Población: Cuidadores de personas con demencia Muestra: Aquellos cuidadores de personas con demencia que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.
				Habitación	
				Volición	
				Ambiente	

Anexo 5: Solicitud de asesora

SOLICITUD PARA ASESOR(A) DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN/TESIS

Director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica - UNMSM

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar asesor(a) para el desarrollo de mi trabajo de investigación / tesis.

DATOS DEL SOLICITANTE	
Estudiante / Egresado:	Estudiante
Apellidos y Nombres:	Rodriguez Arostegui Kelly
Código de matrícula:	18010191
Número de DNI:	75435705
Correo electrónico:	kelly.rodriguez2@unmsm.edu.pe
Número de celular:	913487614
Área:	Terapia ocupacional
TIPO DE TRABAJO	
Bachiller / Título	Título
DATOS DEL DOCENTE NOMBRADO PROPUESTO	
Apellidos y Nombres:	Dra. Joachin del Carpio Mery Margot
Código docente:	0A7639
Número de DNI:	40916720
Correo institucional:	mjoachind@unmsm.edu.pe
Área:	Terapia Ocupacional
Representante de la Escuela Profesional de Tecnología Médica	
Director:	Dr. Miguel Hernán Sandoval Vegas

Agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente:



Datos del solicitante: Kelly Rodriguez Arostegui

DNI:75435705